

CAPÍTULO 9.3

Anemia Ferropénica

PERFIL EUNACOM 1.071.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Anemia Ferropénica

La más frecuente de todas las anemias.

Diagnóstico

- **Hemograma:** microcítica (VCM < 80) + hipocrómica (HCM ↓) + trombocitosis reactiva (plaquetas ↑)
- **Perfil de hierro:** ferritina ↓ + transferrina/TIBC ↑ + saturación ↓

Tratamiento

Hierro oral

- **Dosis:** ~120 mg/día de hierro elemental (clásico: sulfato ferroso 200 mg c/8h) - **Evidencia actual:** 1 sola dosis/día es suficiente y mejor tolerada - **Duración:** continuar **hasta normalizar la ferritina** (generalmente 3–6 meses después de normalizar la Hb) - **Cualquier preparación** de hierro sirve (no hay ventaja del hierro maltosado sobre el sulfato ferroso)

Respuesta al tratamiento

- Reticulocitos ↑ a los 4–7 días - Hb se normaliza ~al mes - Ferritina: tarda meses más

Indicaciones de hierro endovenoso

TABLA 9.3.1: SITUACIÓN VS RAZÓN	
SITUACIÓN	RAZÓN
Insuficiencia renal crónica	Hierro oral no es suficiente
Mala absorción intestinal	No se absorbe por vía oral
3er trimestre del embarazo	Mayor urgencia, necesidad de reposición rápida

Buscar la causa siempre

TABLA 9.3.2: CAUSA VS CONDUCTA	
CAUSA	CONDUCTA
Menstrual abundante	Solo anamnesis, no requiere estudio adicional
Sospecha digestiva (cáncer, EII)	Endoscopia o colonoscopia
Sospecha enfermedad celíaca	Endoscopia alta + anticuerpos anti-transglutaminasa
Causa urinaria	Uroanálisis + buscar hematuria/hemoglobinuria
Uso de aspirina	Preguntar siempre

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Constipación que precede al inicio del hierro → no atribuir al fármaco → colonoscopia para descartar cáncer colorrectal.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 62 años asintomático se realiza chequeo de rutina que evidencia Hemoglobina de 9.4 g/dL con VCM 72 fL y Ferritina de 9 ng/mL. No refiere sangrados visibles por heces ni orina, niega uso de AINEs."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Anemia Ferropénica en Adulto Mayor / Hombre: en hombres adultos y mujeres postmenopáusicas, la anemia ferropénica es SÍNTOMA DE SANGRADO DIGESTIVO hasta demostrar lo contrario. Conducta obligada: Endoscopia Digestiva Alta (EDA) y Colonoscopia total para descartar Cáncer Gástrico y Cáncer Colorrectal. Tratamiento: Sulfato ferroso oral 200 mg/d (60 mg Fe elemental) en ayunas con jugo de naranja (Vitamina C) por 3-6 meses post normalización de Hb.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La anemia ferropénica es la anemia más frecuente y es microcítica, hipocrómica con trombocitosis reactiva
- El diagnóstico se confirma con la caída de la ferritina en el perfil de hierro
- El tratamiento es hierro oral: la evidencia actual recomienda una dosis diaria de 200-400 mg de sulfato ferroso
- Los reticulocitos aumentan a los 4-7 días, el hematocrito se normaliza al mes, pero la ferritina tarda 3-6 meses
- Siempre buscar y tratar la causa: menstrual, digestiva, urinaria o por aspirina
- La enfermedad celíaca es causa importante de ferropenia por afectación del duodeno
- Indicaciones de hierro endovenoso: insuficiencia renal crónica, malabsorción intestinal, tercer trimestre del embarazo
- No hay diferencia significativa entre sulfato ferroso y hierro maltosado según la evidencia

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ANEMIA FERROPÉNICA)

PREGUNTA 1

Mujer de 35 años con anemia ferropénica confirmada, sin menstruaciones abundantes, sin uso de aspirina. Los exámenes de orina son normales. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Iniciar hierro oral y controlar en 6 meses
- B)** Solicitar endoscopia digestiva alta y colonoscopia
- C)** Solicitar biopsia de médula ósea
- D)** Transfundir glóbulos rojos
- E)** Solicitar electroforesis de hemoglobina

PREGUNTA 2

¿En cuál de las siguientes situaciones está indicado el hierro endovenoso?

- A)** Anemia ferropénica leve en mujer premenopáusica
- B)** Paciente con insuficiencia renal crónica en diálisis
- C)** Primer trimestre del embarazo
- D)** Intolerancia gástrica al sulfato ferroso
- E)** Anemia ferropénica con VCM de 70 fL

PREGUNTA 3

Paciente en tratamiento con hierro oral por anemia ferropénica desarrolla constipación 2 semanas después de iniciado el tratamiento. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Suspender el hierro oral definitivamente
- B)** Cambiar a hierro endovenoso
- C)** Reducir la frecuencia del hierro a día por medio o 3 veces por semana
- D)** Solicitar colonoscopia de urgencia
- E)** Agregar laxantes y mantener la misma dosis

RESUMEN: ANEMIA FERROPÉNICA

Esta clase cubre la anemia ferropénica, la anemia más frecuente. Se presenta con síndrome anémico, hemograma con VCM bajo (<80), hipocromía y frecuentemente trombocitosis reactiva. El diagnóstico se confirma con la caída de la ferritina en el perfil de hierro. El tratamiento es hierro oral hasta normalizar la ferritina, lo cual toma 3-6 meses. Los reticulocitos aumentan a los 4-7 días, el hematocrito se normaliza al mes, pero los depósitos de hierro tardan mucho más. La evidencia actual recomienda una sola dosis diaria de 200-400 mg de sulfato ferroso. Es fundamental buscar y tratar la causa: menstrual (anamnesis basta), digestiva (endoscopia/colonoscopia para descartar cáncer o enfermedad celíaca), urinaria (hematuria/hemoglobinuria) y medicamentosa (aspirina). Las indicaciones de hierro endovenoso son: insuficiencia renal crónica, malabsorción intestinal y tercer trimestre del embarazo. Si hay constipación previa al inicio del hierro, se debe descartar cáncer con colonoscopia. Si la constipación es secundaria al hierro, se puede reducir la frecuencia a día por medio o tres veces por semana.